

的可信区间,这就意味着他们的结果与以前发表的研究结论并非不一致。而且,作者依赖资料回忆的诊断方法可能低估了真实的疾病发生率。

毋庸置疑,基因在 RA 患病中起一定作用,至少部分可以用易感性等位基因在 HLA-DRB1 位点来解释⁷。的确如此,在此位点上拥有易感基因可解释为什么一些同卵双胞胎共患 RA,而其他双胞胎不患病⁸。当然 HLA 只能解释基因致病的 50% 的原因⁹,而要想说明易感基因位点致病,比起说明一直处于研究之中的 HLA 致病要困难^{10,11}。

总之,Svendson 等人的研究不能反驳基因在 RA 发病中的易感作用。然而,他们的结论强调了当 RA 的发生有差异时,基因作用比起环境作用相对为弱。这使得想通过大范围连锁研究而揭开 RA 基因作用的工作更加困难。

利益冲突(Competing interests):无申明

(张文 译 董怡 校)

参考文献

1 Jones MA, Silman AJ, Whiting S, Barrett EM, Symmons DPM. Occurrence of rheumatoid arthritis is not increased in the first degree relatives of a population based inception cohort of inflammatory polyarthritis. *Ann Rheum Dis* 1996; 55: 89-93.

2 Cooper GS, Miller FW, Pandey JP. The role of genetic factors in autoimmune disease: implications for environmental research. *Environ Health Perspect* 1999; 107 (suppl 5): 693-700.

3 Aho K, Koskenvuo M, Tuominen J, Kaprio J. Occurrence of rheumatoid arthritis in a nationwide series of twins. *J Rheumatol* 1986; 13: 899-902.

4 Silman AJ, MacGregor AJ, Thomson W, Holligan S, Carthy D, Farhan A, et al. Twin concordance rates for rheumatoid arthritis: results from a nationwide study. *Br J Rheumatol* 1993; 32: 903-907.

5 MacGregor AJ, Snieder H, Rigby AS, Koskenvuo M, Kaprio J, Aho K, et al. Characterizing the quantitative genetic contribution to rheumatoid arthritis using data from twins. *Arthritis Rheum* 2000; 43: 30-37.

6 Phillips DIW. Twin studies in medical research: can they tell us whether diseases are genetically determined? *Lancet* 1993; 341: 1008-1009.

7 Gregersen PK, Silver J, Winchester RJ. The shared epitope hypothesis. An approach to understanding the molecular genetics of susceptibility to rheumatoid arthritis. *Arthritis Rheum* 1987; 30: 1205-1213.

8 Jawaheer D, Thomson W, MacGregor AJ, Carthy D, Davidson J, Dyer PA, et al. "Homozygosity" for the HLA-DR shared epitope contributes the highest risk for rheumatoid arthritis concordance in identical twins. *Arthritis Rheum* 1994; 37: 681-686.

9 Rigby AS, Silman AJ, Voelm L, Gregory JC, Ollier WER, Khan MA, et al. Investigating the HLA component in rheumatoid arthritis: an additive (dominant) mode of inheritance is rejected, a recessive mode is preferred. *Genet Epidemiol* 1991; 8: 153-175.

10 Cornelis F, Faure S, Martinez M, Prud'homme JF, Fritz P, Dib C, et al. New susceptibility locus for rheumatoid arthritis suggested by a genome-wide linkage study. *Proc Natl Acad Sci U S A* 1998; 95: 10746-10750.

11 Jawaheer D, Seldin MF, Amos CI, Chen WV, Shigeta R, Monteiro J, et al. A genomewide screen in multiplex rheumatoid arthritis families suggests genetic overlap with other autoimmune diseases. *Am J Hum Genet* 2001; 68: 927-936.

BMJ 2002;324:264-7

用药点滴
由潘托拉唑和氨甲蝶呤药物相互作用导致的严重肌痛

Drug points
Severe myalgia from an interaction between treatments with pantoprazole and methotrexate

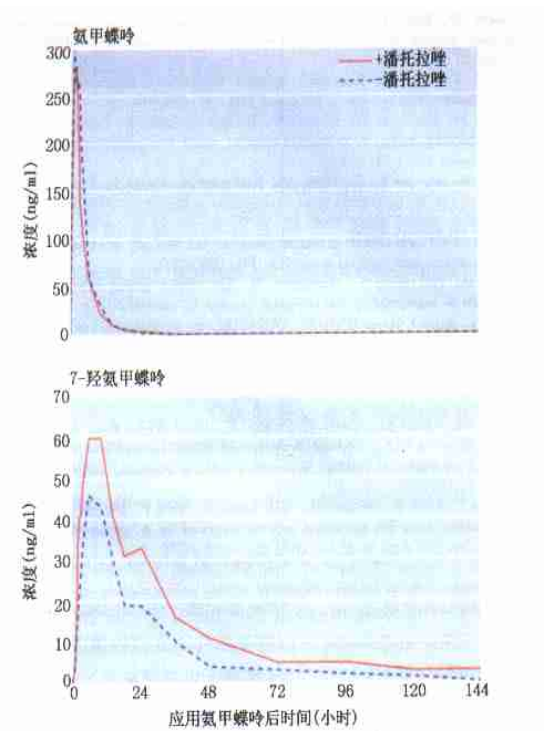
U Tröger, Institute of Clinical Pharmacology, B Stözel, Department of Dermatology and Venerology, J Martens-Lobenhoffer, Institute of Clinical Pharmacology, H Gollnick, Department of Dermatology and Venerology, F P Meyer, Institute of Clinical Pharmacology, Hospital of the Otto-von-Guericke-University, D-39120 Magdeburg, Germany

一位 59 岁的男子因皮肤型滤泡趋向性 T 细胞淋巴瘤接受 2a-干扰素治疗。由于肿瘤复发致治疗中断后,患者开始使用小剂量的氨甲蝶呤(15 mg 肌注,每周 1 次)。同时,因其患有 Barrett 食管和高血压,分别服用潘托拉唑(pantoprazole)(每日 20 mg,口服)和阿替洛尔(atenolol)。在首次注射氨甲蝶呤后,患者出现严重广泛的肌痛和骨痛。以致在注射后的 3 到 4 小时出现部分活动受限,并持续数天,尽管程度有所减轻。上述症状在此后 4 次应用氨甲蝶呤时重复出现。多项的临床和实验室检查除外了潜在的局灶或播散性感染及皮肤型 T 细胞淋巴瘤恶化等原因。由于症状在给药时出现,考虑可能存在某种药物与氨甲蝶呤的相互作用。在用雷尼替丁(ranitidine)替换潘托拉唑后,症状奇迹般地减轻并最终

完全消失。

在得到本人知情同意后,该患者 8 周后再次使用了潘托拉唑。在使用每周 1 次氨甲蝶呤前 6 天开始服用潘托拉唑,以保证达到最大效应。使用高效液体色谱-荧光测定法¹监测使用及不使用潘托拉唑时氨甲蝶呤及其代谢物 7-羟氨甲蝶呤的血清浓度。两次研究间隔 6 周的药物洗脱间期。同时服用阿替洛尔、治疗局部瘙痒的氯马斯丁(clemastine)和治疗暂时性维生素 C 缺乏的抗坏血酸。

合用潘托拉唑时症状再次出现,停用后再次消失。两个时段内氨甲蝶呤的浓度-时间曲线(附图)相似,但 7-羟氨甲蝶呤的两个曲线有显著差异。合用潘托拉唑时,7-羟氨甲蝶呤在给药后 0~144 小时之间的曲线下面积比不合用时高近



附图 合用及不合用潘托拉唑时氨甲蝶呤和7-羟氨甲蝶呤的血清浓度

70%(1929 ng·h/ml 比 1131 ng·h/ml)。当氨甲蝶呤与潘托拉唑合用时,7-羟氨甲蝶呤的半衰期延长 1 倍(81.4 小时比 36.4 小时)。由此提示在肾脏清除过程中的相互作用,而不是代谢中的相互作用。

大约 30% 的患者由于副作用而中断小剂量的氨甲蝶呤治疗。停药的病人中相当一部分是由于药物间的相互作用^{2,3}。接受这一治疗的类风湿关节炎患者有 10%~15% 在用药后出现反应^{4,5}。本报道首次提出氨甲蝶呤服药后反应与 7-羟氨甲蝶呤及同时服用的潘托拉唑相关。本例已向德国国家药物和医疗设备研究所(German Federal Institute for Drugs and Medical Devices)和德国医疗专业药物委员会(Drug Commission of the German Medical Profession)通报。氨甲蝶呤的生产者(Medac GmbH, Wedel, 德国)没有注意到这一药物间的相互作用。

资助(Funding):无

利益冲突(Competing interests):无申明

(吴晰 译 陆星华 校)

本文参考文献从略,本编辑部承索提供,读者也可经 bmj.com 网址免费浏览。

BMJ 2002;324:1497

观察与视点

一位难忘的病人 善意的谎言

A memorable patient
A lie softly spoken

她的身体看上去就像是红黑相间的补丁一样,浑身都散发着烧焦的毛发和肉的臭味,从腿和脚渗出的液体嘀嗒嘀嗒地淌着。这位妇女是因炉子的火引着了睡衣而被烧成这样的,更可怕的是几个小时以后才被人发现。尽管她在入院时还会偶尔地清醒过来,但我初步判断她会很快死去。

我机械地给她输液、插导管,完成一整套救治的措施。第二次检查肯定了我的初步诊断,70% 以上的烧伤面积,岁数又这么大,还有什么救活的希望呢? 在她身边也没有亲属,我们最后决定,对她精心护理,以尽可能的保证舒适,并允许其死亡。在注入吗啡几小时后,她安静地死去了。

在照顾她时,我做的最有意义的事就是在准备注射麻醉剂时轻轻地对她说:“想想你向往的美好事情吧,一会儿你就

睡着了,就不觉得疼了,你会好的。”这些年经过无数次地重复,这些谎言已经能从 my 口中脱口而出了。

在处理完这位病人后,我冲了两次澡,然后又带着儿子去幼儿园、买东西、在屋子周围遛来遛去。就是这样 24 小时以后,我还是觉得身上有烧焦的味道,眼前不断闪现她那令人恐怖的情景,以及痛苦、无助的神情。我们都不能预见死亡,也不能选择死亡的方式,但我们肯定都不愿意被烧死,都希望在自己的家里安静地死去。但是即使是像这位妇女那样痛苦地死去,在面临死亡的时刻,我们仍然需要相互之间的交流,紧紧握着病人的手要比简单的抢救操作有意义得多。

或许这个故事能说明一个一直令人困惑的问题,就是当医生在处理此类病人时,是应该残酷地告诉他们事实呢? 还是应该在适当的时候对病人撒谎呢? 在相同的情况下,我想我还是会用善意的谎言安慰病人。要是你,你会如何做呢?

关于作者:Ian Nesbitt, consultant in anaesthesia and intensive care.

(尹惠兰 译 潘 校)

BMJ 2002;324:1122